EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob os nº 06.954.942/0001-95, com sede à SCS Quadra 2 Bloco C Lote 104, nº 252, 5º andar, Asa Sul, Brasília-DF, neste ato representado por sua Presidente, PAULA BERMUDES MORAES CORADI, vem, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados infra-assinados, com instrumento procuratório anexo e endereço para intimações no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 1, Bloco M, Edifício Libertas, salas 1310/1311, Asa Sul, Brasília, DF, CEP 70.070-935, e-mail: juridico@cittadino.adv.br, com fundamento no art. 102, §1º, da Constituição Federal e nos dispositivos da Lei nº 9.882/99, propor

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face da **Resolução nº 2.427, de 8 de abril de 2025, do Conselho Federal de Medicina (CFM)**, publicada em 16 de abril de 2025, que **disciplina de maneira inconstitucional os critérios éticos e técnicos para o atendimento de pessoas com incongruência e/ou disforia de gênero**, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. LEGITIMIDADE E CABIMENTO DA ADPF

a. DA LEGITIMIDADE ATIVA:

A legitimidade ativa do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) - enquanto partido político com representação no Congresso Nacional - fundamenta-se no art. 2º, I, da Lei 9.882/1999, que estabelece como legitimados para propor Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental todos aqueles já elencados no art. 103 da Constituição Federal.

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com representação de quatorze parlamentares no Congresso Nacional, cumpre com o requisito de representação disposto no art. 103, VIII, da CF.

Em relação à matéria arguida, esta Suprema Corte já reconheceu partidos políticos como legitimados universais, não se exigindo a demonstração de pertinência temática para o ajuizamento de ação em sede de controle abstrato. Assim, nos termos do Ministro Celso de Mello, está garantida a possibilidade de "*arguir perante o Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade de atos normativos federais, estaduais ou distritais, independentemente de seu conteúdo material, eis que não incide sobre as agremiações partidárias a restrição jurisprudencial derivada do vínculo de pertinência temática*".[1]

Configurada, portanto, a legitimidade para ajuizamento desta ADPF.

b. DO CABIMENTO DA ADPF:

O cabimento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) está previsto no artigo 102, §1º, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 9.882/199, pois visa reparar lesão a preceitos fundamentais causada por ato normativo de natureza secundária editado por autarquia federal – a Resolução CFM nº 2.427/2025, do Conselho Federal de Medicina. Tal resolução impõe restrições desproporcionais e anticientíficas ao acesso de pessoas trans a terapias afirmativas de gênero, violando frontalmente o princípio da dignidade da

[1] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.407. Relator: Min. Celso de Mello. Brasília, DF, 7 de março de 1996. Diário da Justiça, p. 86, Brasília, DF, 24 nov. 2000. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14702386/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-1407-df>.

pessoa humana, o direito à saúde integral, à identidade de gênero autopercebida e à proteção integral da criança e do adolescente.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, a ADPF é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público. O parágrafo único do referido artigo esclarece que tal cabimento também se aplica a *"lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição"*, especialmente quando *"for relevante o fundamento da controvérsia constitucional"*.

No caso, a **Resolução CFM nº 2.427/2025** – ato normativo de caráter geral e efeitos *erga omnes*, emanado de autarquia federal integrante da administração pública indireta – **extrapola os limites do poder regulamentar ao instituir, de forma autônoma e sem respaldo legal, restrições graves ao exercício de direitos fundamentais, caracterizando inovação normativa de conteúdo primário**. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte *"(...) admite a apreciação excepcional, em controle abstrato de constitucionalidade, da validade de atos de entidades públicas que importam em regulamentação de matéria cuja competência se pretende tenha sido exercida em exorbitância aos limites constitucionais. (...) Por isso, normas editadas pelos órgãos e entidades administrativas não podem inovar a ordem jurídica, ressalva feita à expressa autorização constitucional e não com o objetivo de restringir direitos fundamentais. (...)"* (ADPF 532 MC/DF).

Nesse sentido, é inquestionável que atos normativos infralegais que excedem sua função regulamentar e inovam no ordenamento jurídico em detrimento de direitos fundamentais sujeitam-se ao controle concentrado de constitucionalidade.

Ademais, o requisito da subsidiariedade previsto no art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999 encontra-se plenamente atendido. Inexiste outro meio processual eficaz que permita sustar, de maneira ampla, definitiva e vinculante, os efeitos lesivos da norma impugnada. O controle difuso ou a atuação em sede de ações individuais não são capazes de solucionar, com a generalidade e eficácia exigidas, a controvérsia constitucional posta, tampouco evitar a multiplicação de decisões contraditórias nos tribunais.

Conforme entendimento reiterado desta Corte, a subsidiariedade deve ser interpretada à luz da efetividade da tutela dos preceitos fundamentais (cf. ADPF 76 e ADPF 388), de modo que a mera existência de outras vias formais não basta para

afastar o cabimento da ADPF se estas forem incapazes de impedir ou reparar, em sua plenitude, a lesão constitucional.

Por fim, a urgência e relevância da controvérsia tornam ainda mais evidente a necessidade de pronunciamento definitivo e vinculante deste Supremo Tribunal Federal, única instância constitucionalmente habilitada a julgar a presente ação. Assim, restam preenchidos todos os requisitos formais e materiais para o pleno conhecimento da presente ADPF.

c. DA PREVENÇÃO:

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental possui **identidade fático-jurídica com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7806 e com a ADPF nº 1221**, ambas **voltadas à impugnação da Resolução CFM nº 2.427/2025** e já **distribuídas ao Ministro Cristiano Zanin**. Os fundamentos e pedidos das referidas ações coincidem substancialmente com os ora apresentados, notadamente quanto à inconstitucionalidade da norma impugnada por violação aos direitos fundamentais à saúde, à identidade de gênero e à proteção integral de crianças e adolescentes trans.

Nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a regra de distribuição por prevenção sempre que houver coincidência total ou parcial de objetos:

> *"Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos."*

Considerando que a ADPF nº 1221 já foi preventa à ADI nº 7806, impõe-se a aplicação da mesma regra à presente arguição, a fim de preservar a unidade da jurisdição constitucional e evitar decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia.

Diante disso, requer-se a distribuição da presente ADPF por prevenção ao Ministro Cristiano Zanin, Relator da ADI nº 7806 e da ADPF nº 1221.

II. DA NORMA IMPUGNADA

A **Resolução CFM nº 2.427, de 8 de abril de 2025**, editada pelo **Conselho Federal de Medicina (CFM)**, que **restringiu de forma significativa** os direitos das pessoas com incongruência de gênero ao acesso a atendimentos médicos, promovendo **um grave retrocesso em relação ao marco regulatório anterior**, estabelecido pela **Resolução CFM nº 2.265/2019**.

A **Resolução CFM nº 2.265/2019**, revogada pelo ato impugnado, estabelecia um modelo de **atenção integral**, baseado em um **Projeto Terapêutico Singular**, a ser elaborado por **equipe multiprofissional** e **interdisciplinar**, com o objetivo de assegurar **atendimento individualizado, acolhimento humanizado e acesso progressivo à hormonioterapia e aos procedimentos cirúrgicos, respeitando a autonomia do indivíduo** e a **evidência científica vigente**.

Em especial, previa a possibilidade de:

- **Bloqueio hormonal da puberdade** a partir do estágio Tanner II (fase inicial da puberdade) para adolescentes trans, dentro de protocolos éticos de pesquisa e assistência;
- **Hormonioterapia cruzada** (administração de hormônios sexuais condizentes com a identidade de gênero) a partir dos 16 anos, mediante acompanhamento médico especializado;
- **Procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero** a partir dos 18 anos, observando requisitos de acompanhamento prévio mínimo e respeito à autonomia informada do atendido.

Esse marco normativo refletia, ainda que com ressalvas, **os avanços científicos internacionais**, alinhando-se à **CID-11** da Organização Mundial da Saúde, que **retirou a incongruência de gênero do rol das patologias mentais**, e às práticas de promoção da saúde integral para pessoas trans, conforme diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral LGBT do SUS.

Em sentido contrário, a nova **Resolução CFM nº 2.427/2025 retrocedeu significativamente**, ao:

- **Proibir totalmente** a prescrição de **bloqueadores hormonais para adolescentes** com incongruência de gênero (art. 5º), salvo em casos de doenças endócrinas específicas, dissociadas da identidade de gênero;
- **Vedar a hormonioterapia cruzada para menores de 18 anos** (art. 6º, §2º), mesmo sob acompanhamento médico especializado, negando o direito de adolescentes trans ao desenvolvimento corporal compatível com sua identidade de gênero;
- **Impedir a realização de procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero** antes dos **21 anos**, nos casos que impliquem potencial efeito esterilizador (art. 7º, §3º, III), criando barreiras inéditas e desproporcionais não previstas na legislação anterior;
- **Reintroduzir a patologização** da experiência trans, ao condicionar o atendimento médico à formulação de diagnósticos psiquiátricos baseados em critérios do DSM-5-TR, tratando a identidade de gênero diversa como um "sofrimento patológico" (art. 1º, III).

Tais medidas colidem com um amplo conjunto de **evidências científicas nacionais e internacionais**[1] que demonstram os prejuízos da restrição imposta:

1. **Bloqueadores hormonais:** Estudos como os de **Turban et al. (2020)** e **Herrera Jerez et al. (2024)** comprovam a segurança e os efeitos positivos desses medicamentos, inclusive na redução da ideia suicida. A proibição absoluta, além de agravar o sofrimento psíquico de jovens trans, inviabiliza projetos de pesquisa clínica.
2. **Hormonioterapia cruzada**: As diretrizes da **Endocrine Society (Hembree et al., 2017)** e da **WPATH (2022)** autorizam o início criterioso a partir dos 16 anos, amparadas em estudos longitudinais como os de **Tordoff et al. (2022)** e **Tangpricha et al. (2019)**, que relacionam o atendimento precoce a melhores indicadores de saúde mental.
3. **Desconsideração do caráter de pesquisa dos atendimentos no Brasil**: O uso de bloqueadores e hormônios em adolescentes vinha sendo realizado sob

estritos protocolos de pesquisa com aprovação ética do **Sistema CEP/CONEP**, conforme demonstrado por **Saadeh & Scivoletto (2024)**.

4. **Benefícios psicossociais do cuidado afirmativo**: Revisões sistemáticas como as de **Wittlin et al. (2023)**, **Rew et al. (2021)**, **Rosenthal (2021)** e **Tangpricha et al. (2019)** demonstram a eficácia de abordagens afirmativas na redução da depressão, ansiedade e risco suicida.

5. **Contradição com o Projeto Terapêutico Singular**: Ao estabelecer barreiras etárias fixas e diagnósticos patologizantes, a resolução contradiz seu próprio discurso de individualização do cuidado.

6. **Ofensa ao ECA e à bioética**: Viola-se o direito à saúde, a autonomia progressiva do adolescente e a prerrogativa dos Comitês de Ética em Pesquisa, comprometendo o desenvolvimento científico e a segurança assistencial.

Assim, a **Resolução CFM nº 2.427/2025**, ao restringir o acesso a acompanhamentos reconhecidos como fundamentais para o bem-estar psicossocial e físico das pessoas trans, **viola diretamente**:

- O **direito à saúde** (arts. 6º, 196 e 198 da Constituição);
- O **princípio da dignidade da pessoa humana** (art. 1º, III);
- O **direito ao livre desenvolvimento da personalidade**;
- A **proteção integral da criança e do adolescente** (art. 227);
- O **princípio da igualdade e da vedação à discriminação** (art. 5º, caput e incisos XLI e XLII).

Além disso, a edição da **Resolução CFM nº 2.427/2025** contraria frontalmente o **princípio da vedação ao retrocesso social**, pois **subtrai direitos fundamentais já consagrados pela normativa anterior**, **sem qualquer fundamentação científica** e sem observância dos parâmetros internacionais de direitos humanos.

O retrocesso institucionalizado pela norma impugnada agrava-se, ainda, pelo fato de comprometer o acesso à saúde pública no âmbito do SUS, violando a política

pública consolidada pela Portaria GM/MS nº 2.803/2013, que regula o Processo Transexualizador.

Desse modo, o **ato normativo ora impugnado se revela incompatível com a Constituição da República, impondo severas restrições a direitos fundamentais sob o pretexto de revisão ética**, mas **sem respaldo científico consistente**, o que justifica a sua invalidação por meio da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

III. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.427/2025

a. DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – RESTRIÇÃO DE DIREITOS POR MEIO DE RESOLUÇÃO

A Resolução CFM nº 2.427/2025 incorre em manifesta **inconstitucionalidade formal ao extrapolar os limites legais e constitucionais do poder regulamentar atribuído ao Conselho Federal de Medicina**. Conforme dispõe o art. 5º, II, da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Trata-se do núcleo do princípio da legalidade, que veda à Administração Pública – direta ou indireta – a imposição de obrigações ou restrições a direitos fundamentais sem fundamento em norma legal formalmente válida. O STF inclusive já se posicionou no sentido de que:

> *(...) Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal."(AC 1.033 AgR-QO, rel. min. Celso de Mello, j. 25-5-2006, P, DJ de 16-6-2006.)*

A **Lei nº 3.268/1957**, que disciplina a estrutura e as competências do CFM, **não confere à autarquia poder normativo para restringir o acesso de pessoas a tratamentos ou acompanhamentos de saúde**. Ao contrário, seu art. 5º **limita expressamente as atribuições do órgão**, restringindo seu poder normativo à **edição de regras de ética médica**, especialmente no que diz respeito ao Código de Deontologia Médica. Portanto, **inexiste autorização legal para que o CFM edite norma que proíba, de forma absoluta, terapias afirmativas que visam assegurar**

a saúde mental e o bem-estar físico de pessoas trans – ainda mais quando amparadas por evidências científicas consolidadas.

Não se ignora que o CFM possa agir diante de condutas médicas que coloquem em risco a vida ou a integridade dos atendidos, sempre com fundamento em parâmetros científicos e éticos. Entretanto, a **Resolução CFM nº 2.427/2025** não se limita a orientar condutas médicas segundo critérios técnicos. Ela **inova no ordenamento jurídico ao estabelecer, sem respaldo legal, vedações absolutas ao uso de bloqueadores hormonais em adolescentes trans, à hormonização antes dos 18 anos, além de proibir a realização de procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero antes dos 21 anos.**

Conforme reiterada jurisprudência do STF, nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, o que somente pode ser feito por meio de lei em sentido estrito.

A Resolução ora impugnada incorre, ainda, em violação direta aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, II), da separação dos poderes (art. 2º) e do devido processo legislativo (art. 5º, LIV). O CFM, ao editar norma que inova o ordenamento jurídico sem respaldo legislativo, invade competência reservada ao Poder Legislativo, usurpando função típica do Congresso Nacional e afrontando o devido processo legislativo constitucionalmente instituído.

A título ilustrativo, a jurisprudência do STF admite a submissão ao controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos secundários que extrapolam os limites do poder regulamentar e inovam indevidamente em matéria reservada à lei (cf. ADPF 532 MC/DF). A Corte reconhece que **normas infralegais não podem restringir direitos fundamentais nem criar obrigações aos administrados**, salvo quando autorizadas por lei, o que não se aplica ao caso em apreço.

A Resolução CFM nº 2.427/2025 viola esse entendimento ao **criar uma verdadeira interdição de acesso a atendimentos consagrados e respaldados por evidências médicas nacionais e internacionais**. Trata-se de uma **vedação absoluta e generalizada, sem previsão legal, aplicada a toda a população trans em fase de desenvolvimento, com graves repercussões sobre seus direitos à saúde, ao livre desenvolvimento da personalidade e à identidade de gênero**.

Frisa-se que a norma impugnada **interrompe uma política pública implementada há 15 anos no Brasil**[2], com investimentos em pesquisa, atendimentos e elaboração de planos individualizados. Tem-se, pois, que um ato do CFM está determinando os ditames de um projeto governamental já consolidado, o que claramente envolve **impacto orçamento e gestão de recursos públicos**. Inclusive, a norma afeta diretamente oito instituições públicas em todo o Brasil, quais sejam: i. o Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual (Amtigos), vinculado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo; ii. o Centro de Saúde Escola Barra Funda, da Santa Casa de São Paulo; iii. o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); iv. o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); v. o Hospital Universitário Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia (UFBA); vi. a Policlínica Lessa de Andrade, da rede municipal de saúde do Recife; vii. o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e viii. o programa Aquarela, vinculado ao Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).[3]

Tem-se que a Resolução CFM nº 2.265/2019, revogada pela Resolução ora impugnada, trazia parâmetros para a realização da assistência médica voltada para a pessoa transgênero. Quando se trata de garantir acesso a direitos não há limitação de ordem jurídico-normativa, razão pela qual a repristinação da antiga Resolução é medida que efetiva direitos constitucionalmente consagrados. Afastada a força normativa da Resolução CFM nº 2.265/2019, retoma-se a cogência da Resolução CFM nº 2.265/2019, que regulamenta a atenção integral à saúde do transgênero.

Diante do exposto, resta evidenciada a inconstitucionalidade formal da Resolução CFM nº 2.427/2025 em razão da extrapolação de competência da autarquia editora, da ausência de autorização legal para restrição de direitos

[2] GONÇALVES, Andre Henrique Oliveira. Protocolos do AMTIGOS In: SAADEH, Alexandre; SCIVOLETTO, Sandra (coords). Incongruência de gênero: infância, adolescência e fase adulta da vida. SANTANA DE PARNAÍBA: Manole, 2024. p. 406-23

[3] AVELAR, Dani. Veja quais unidades do SUS atendem crianças e adolescentes trans. Folha de S.Paulo, São Paulo, 22 maio 2022. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/2022/05/veja-quais-unidades-do-sus-atendem-criancas-e-adolescentes-trans.shtml. Acesso em: 2 maio 2025.

fundamentais, da afronta ao devido processo legislativo e à separação dos poderes, tudo a ensejar a repristinação dos efeitos da Resolução CFM nº 2.265/2019.

b. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA

A Resolução CFM nº 2.427/2025 **vulnera de maneira grave e direta** direitos fundamentais consagrados na Constituição da República, afetando especialmente o **livre desenvolvimento da personalidade**, o **direito fundamental à saúde** e o **princípio da dignidade da pessoa humana**, previstos, respectivamente, nos artigos 5º, caput e inciso LIV, 6º, 196 e 1º, inciso III, da Constituição.

Ao impedir o acesso de adolescentes transgêneros ao bloqueio da puberdade, à hormonização cruzada antes dos 18 anos e ao retardar cirurgias de afirmação de gênero para depois dos 21 anos, a norma impugnada impede o pleno exercício da autonomia pessoal e **reforça estruturas discriminatórias que negam às pessoas trans o reconhecimento de sua identidade, fomentando a exclusão social e o sofrimento psíquico**.

A dignidade da pessoa humana — valor-fonte da ordem constitucional (art. 1º, III) — exige o **respeito à autodeterminação** e ao **direito de cada indivíduo construir livremente sua identidade**, sem a imposição de normas patologizantes ou discriminatórias. Nesse sentido, como assentado na ADI 4275, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que:

> (...) A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. (...)
>
> (ADI 4275, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-045 DIVULG 06-03-2019 PUBLIC 07-03-2019)

De igual modo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Opinião Consultiva OC-24/17[4], consignou que a identidade de gênero é protegida pela Convenção Americana de Direitos Humanos como **expressão da dignidade humana e da não discriminação**.

Portanto, **ao barrar atendimentos reconhecidos como essenciais para o bem-estar de pessoas trans**, a Resolução impugnada **afronta o núcleo essencial dos direitos de personalidade, saúde e dignidade**, impondo-se seu controle de constitucionalidade.

c. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A Resolução CFM nº 2.427/2025 **viola frontalmente o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes** (CF, art. 227). Ao **proibir categoricamente** o uso de bloqueadores hormonais e **vedar a hormonização cruzada antes dos 18 anos**, a norma compromete o direito fundamental ao desenvolvimento saudável e à saúde integral de adolescentes trans, embasando-se em argumentos anticientíficos e contrários à jurisprudência constitucional.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) consagra o **princípio da autonomia progressiva**, garantindo aos adolescentes o direito de participar, conforme seu grau de desenvolvimento, das decisões sobre sua saúde (ECA, arts. 7º e 11). Desse modo, a resolução impugnada ignora essa diretriz ao impor **restrições genéricas e inflexíveis** mesmo diante de pareceres médicos individualizados e acompanhamento por equipes multiprofissionais especializadas.

Em contraste com a narrativa de pretensa proteção adotada pelo CFM, as **evidências técnico-científicas disponíveis** demonstram que o **bloqueio puberal** (uso de análogos de GnRH) é uma intervenção segura, **reversível** e com **finalidade diagnóstica**. Trata-se de um *"intervalo diagnóstico"* que **"pausa"** temporariamente a puberdade, permitindo que o adolescente trans possa explorar sua identidade de gênero **sem que características sexuais secundárias irreversíveis avancem**.

[4] **Corte Interamericana de Direitos Humanos. Parecer Consultivo Consultiva OC-24/17**. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_por.pdf.

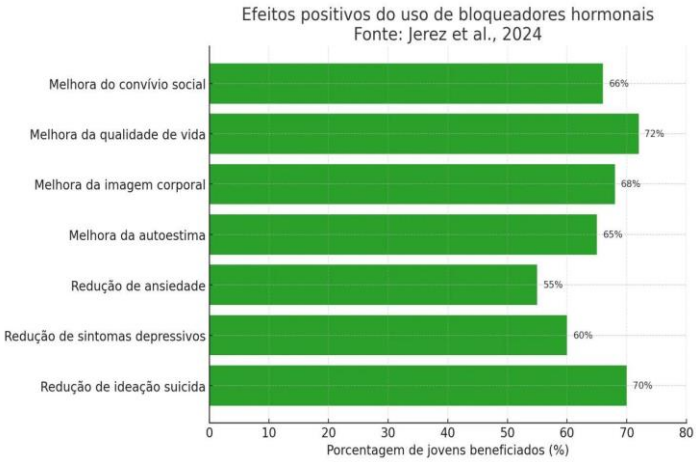
Diversas sociedades médicas recomendam e aprovam essa prática diante da incongruência de gênero na adolescência, ressaltando seu histórico de uso seguro por décadas em outras condições (como puberdade precoce)[5]. **Ao suspender o progresso puberal, os bloqueadores oferecem tempo** para confirmação da persistência da identidade trans, **evitando mudanças corporais indesejadas que, mais tarde, demandariam intervenções cirúrgicas invasivas**.

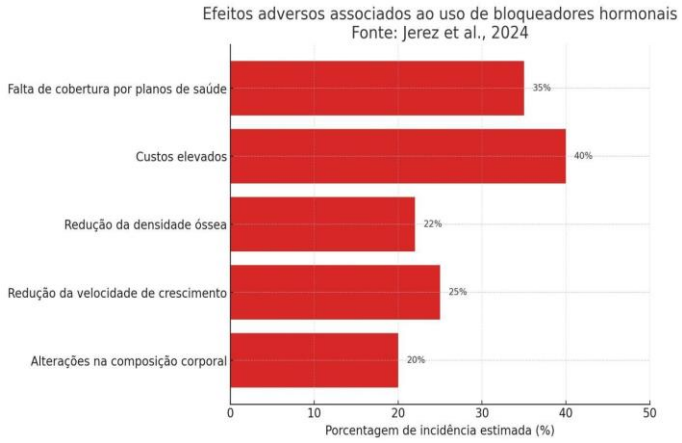
Importante destacar que **os efeitos dos bloqueadores são totalmente reversíveis**: uma vez interrompida a medicação, o eixo hormonal retoma sua atividade e a puberdade prossegue. Nesse sentido, os especialistas referem que o bloqueio puberal funciona como um *"amortecedor"* necessário, **prevenindo o desenvolvimento de traços físicos** (como seios, voz grossa, pelos faciais, menstruação) que **atuam como gatilho de profundo sofrimento psíquico nos jovens trans**[6]. Adolescentes trans e suas famílias valorizam essa possibilidade de adiar a puberdade exatamente por **prevenir uma incongruência grave com o corpo e dificuldades de convívio social** durante a adolescência. Por outro lado, vedar completamente essa intervenção faz com que **traços biológicos irreversíveis se consolidem**, agravando o sofrimento e dificultando a futura integração social desses jovens.

A importância do bloqueio puberal e de demais cuidados afirmativos precoces para a saúde mental está amplamente documentada. Estudos longitudinais indicam que **adiar a puberdade de forma assistida reduz drasticamente indicadores de depressão, ansiedade e ideação suicida em adolescentes trans**[7]. Por exemplo, Turban et al. (2020)[8], analisando mais de 20 mil pessoas trans, observaram que aqueles que tiveram acesso a bloqueadores hormonais na adolescência apresentaram cerca de

[5] National Library of Medicine. Disponível: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9793415/#:~:text=luteinizing%20hormone%2C%20and%20gonadal%20hormones%2C,are%20separate%20phases%20in%20transgender
[6] MARACCINI. Veto à terapia hormonal para jovens trans preocupa médicos; entenda. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/veto-a-terapia-hormonal-para-jovens-trans-preocupa-medicos-entenda/#:~:text=%E2%80%9CO%20que%20n%C3%B3s%20faz%C3%ADamos%2C%20anteriormente%2C,feito%20seguindo%20crit%C3%A9rios%20rigorosos%E2%80%9D%2C%20completa
[7] GRAY, Richard. Use of Hormone Blockers in Transgender Teenagers: A Scoping Review. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11676889/#:~:text=%2A%20.
[8] TURBAN, Jack, et tal. Pubertal Suppression for Transgender Youth and Risk of Suicidal Ideation. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31974216/#:~:text=Results%3A%20%20Of%20the%20sample%2C,0.6

70% menos chances de ideação suicida ao longo da vida comparados aos que necessitavam, mas não tiveram acesso a esse acompanhamento.[9]





De igual modo, revisões sistemáticas recentes confirmam **melhora significativa do bem-estar psicológico e social** com o uso apropriado de bloqueadores: há **redução dos sintomas depressivos, da automutilação e das tendências suicidas**, bem como **ganhos em qualidade de vida, autoestima e satisfação corporal**. No contexto latino-americano, Herrera Jerez et al. (2024)[10] compilam evidências que apontam **melhora substancial na saúde mental de adolescentes trans durante e após o uso de bloqueadores hormonais**, sem registro de efeitos adversos graves. Em termos práticos, isso se traduz em jovens mais participativos na escola, com menor evasão, e capazes de projetar um futuro com identidade reconhecida.

Cabe salientar que **nenhuma intervenção medicamentosa é realizada em crianças pré-púberes – antes do estágio Tanner II de desenvolvimento –**, sendo o acompanhamento dessa faixa etária limitado à **transição social de gênero** e **apoio psicossocial**. A **transição social** (adoção de nome, pronomes e expressão de gênero condizentes) por si só já traz benefícios: crianças trans que vivenciam essa transição em ambiente acolhedor apresentam **melhor saúde mental e menor incidência de**

[9] JEREZ, Herrera M. J. et tal. Use of Hormone Blockers in Transgender Teenagers: A Scoping Review. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11676889/#:~:text=hormone%20blockers%20in%20transgender%20adolescents,of%20life%20and%20life%20satisfaction

[10] JEREZ, Herrera M. J. et tal. Use of Hormone Blockers in Transgender Teenagers: A Scoping Review. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11676889/#:~:text=hormone%20blockers%20in%20transgender%20adolescents,of%20life%20and%20life%20satisfaction

***bullying* escolar**, quando comparadas àquelas cuja transição é postergada para a adolescência. Isso evidencia que o **apoio desde cedo** – familiar, escolar e médico – contribui para a **proteção da identidade e dignidade da criança**, diminuindo riscos de isolamento e sofrimento[11].

Constata-se, portanto, que a política de **"espera obrigatória" imposta pela Resolução CFM nº 2.427/2025 é, além de inconstitucional, uma violência institucional contra adolescentes trans**. Forçar esses jovens a atravessar uma puberdade incongruente com sua identidade equivale a expô-los a **estresse intenso e evitável**. O período da puberdade, sobretudo a partir do estágio Tanner II, é justamente quando surgem os caracteres sexuais secundários irreversíveis – e com eles, frequentemente, o **agravamento da incongruência de gênero**. Pesquisas clínicas demonstram que o **adiamento forçado de cuidados afirmativos leva ao agravamento de transtornos psiquiátricos**: Sorbara et al. (2020)[12] verificaram que adolescentes trans que **iniciaram acompanhamento médico mais tardiamente (ou seja, já em puberdade avançada)** apresentaram **incidências significativamente maiores de depressão, automutilação e tentativas de suicídio** do que aqueles que obtiveram assistência ainda no início da adolescência. Em seu estudo com 300 jovens, aqueles que chegaram ao serviço **após a metade da puberdade relataram ideação suicida em 52% dos casos, vs. 40% entre os que foram atendidos antes dos 15 anos**; tentativas de suicídio ocorreram em 17% dos casos tardios vs. 9% nos precocespubmed.ncbi.nlm.nih.gov. O atraso no cuidado médico adequado também esteve associado a um risco **5,5 vezes maior de diagnóstico de depressão e 4 vezes maior de transtorno de ansiedade** entre os adolescentes em puberdade avançada. **Tais dados concretos desmentem qualquer suposição de que "não intervir" seria benéfico – ao contrário, a demora imposta potencializa o sofrimento psíquico e compromete direitos básicos à saúde mental**.

---

[11] TURBAN, Jack, et tal. Pubertal Suppression for Transgender Youth and Risk of Suicidal Ideation. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31974216/#:~:text=Results%3A%20%20Of%20the%20sample%2C,0.6

[12] SORBARA, Joanna C. et al**.** Mental health and timing of gender-affirming care. *Pediatrics*, v. 146, n. 4, 2020. DOI: 10.1542/peds.2020-011202. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32958610/#:~:text=Results%3A%20%20Of%20300%20youth%2C,1.63

Ademais, é importante contextualizar que **no Brasil o acesso a bloqueadores hormonais na adolescência já era extremamente restrito e criterioso** mesmo antes da nova resolução. Diferentemente de alguns países que recentemente revisaram protocolos, aqui **essas terapias vinham ocorrendo somente em âmbito de pesquisa clínica supervisionada e com critérios rígidos de elegibilidade**. A antiga Resolução CFM nº 2.265/2019 – ora revogada – **permitia o bloqueio puberal apenas a partir do início da puberdade (Tanner II) e dentro de projetos de pesquisa aprovados pelos Comitês de Ética (CEP/CONEP)**. Na prática, conforme demonstrado por meio da CNN Brasil:

> (...) O que nós fazíamos, anteriormente, enquanto intervenções, era postergar a puberdade, porque entendemos que o sofrimento psíquico, chamado disforia, aparece justamente quando os caracteres secundários, como contornos corporais, seios, menstruação ou pelos faciais, surgem. Isso acaba agindo como um gatilho para esses sofrimentos", explica Nasser. "Até a resolução antiga, isso era feito em um modelo de pesquisa. Em São Paulo, por exemplo, que é o estado mais rico e populoso do país, apenas um centro fazia o bloqueio puberal. E isso era feito seguindo critérios rigorosos (...)[13]

Conforme relato da equipe do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual (AMTIGOS/USP)[14], nenhum adolescente iniciava bloqueadores ou hormônios sem **avaliação conjunta de pediatras, psiquiatras e psicólogos especializados**, e **todos os casos** eram conduzidos no âmbito hospitalar universitário, com monitoramento contínuo de parâmetros de saúde (densidade óssea, crescimento, exames laboratoriais). **Não havia, portanto, "banalização" ou uso indiscriminado**: ao contrário, o Brasil mantinha um modelo cauteloso e altamente supervisionado, **mais exigente inclusive do que protocolos de países como Canadá, EUA ou mesmo da Europa Escandinava**. As restrições adicionais sugeridas por revisões estrangeiras – *v.g.* o **Relatório Cass britânico**, que recomendou critérios rigorosos para início de bloqueadores – **já eram plenamente atendidas pelos serviços brasileiros**. Nesse cenário, a proibição absoluta imposta

[13] MARACCINI. Veto à terapia hormonal para jovens trans preocupa médicos; entenda. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/veto-a-terapia-hormonal-para-jovens-trans-preocupa-medicos-entenda/#:~:text=%E2%80%9CO%20que%20n%C3%B3s%20faz%C3%ADamos%2C%20anteriormente%2C,feito%20seguindo%20crit%C3%A9rios%20rigorosos%E2%80%9D%2C%20completa.
[14] GONÇALVES, Andre Henrique Oliveira. Protocolos do AMTIGOS In: SAADEH, Alexandre; SCIVOLETTO, Sandra (coords). Incongruência de gênero: infância, adolescência e fase adulta da vida. SANTANA DE PARNAÍBA: Manole, 2024. p. 410.

pelo CFM frustra **até mesmo projetos de pesquisa em andamento**, paralisando serviços altamente especializados que vinham acumulando dados positivos e aprimorando a segurança do cuidado prestado.

A fim de demonstrar a seriedade e o rigoroso procedimento para atendimento às pessoas trans no Brasil, junta-se, em anexo, Documento 08, no qual há o cotejo entre as recomendações do Relatório Cass (utilizado pelo Reino Unido e citado como argumento pelo Conselho Federal de Medicina para edição da resolução ora impugnada) e o procedimento utilizado para atendimento no Brasil, tendo como referência o procedimento adotado pelo ambulatório AMTIGOS. Da análise, afere-se que o procedimento brasileiro é mais rigoroso do que o britânico, razão pela qual o argumento do CFM de que nossos métodos são frágeis/insuficientes não prospera.

Em suma, **a normativa impugnada afronta diretamente os direitos fundamentais de adolescentes trans** à saúde, à integridade física e psicológica e ao livre desenvolvimento da personalidade. Ao retirar **ferramentas terapêuticas essenciais e consagradas** do arsenal médico – como o bloqueio puberal, reconhecido mundialmente por seu **papel protetor e diagnóstico** – a Resolução nº 2.427/2025 incorre em **flagrante violação do princípio da dignidade da pessoa humana** (CF, art. 1º, III) e do **dever de proteção especial à infância e juventude** (CF, art. 227). Não se trata apenas de escolha de política de saúde, mas de **negação de direitos básicos a uma parcela vulnerável da população**, em desacordo com a melhor evidência científica. Impõe-se, assim, a atuação desse E. Supremo Tribunal Federal para restabelecer a ordem constitucional violada, garantindo-se a efetividade dos preceitos fundamentais em questão.

d. Da Repatologização das Identidades Trans e da Vedação ao Retrocesso:

A Resolução CFM nº 2.427/2025 incorre em dupla violação constitucional: promove a inadmissível **repatologização das identidades trans** e, ao mesmo tempo, configura um flagrante **retrocesso em direitos fundamentais** já consolidados.

A **Organização Mundial da Saúde** (OMS), por meio da Classificação Internacional de Doenças – CID-11, **retirou a incongruência de gênero do rol de transtornos mentais e comportamentais**, reconhecendo que tratá-la como enfermidade é causa de estigma, exclusão e sofrimento. Conforme afirmou a própria em tradução livre[15]:

> "Isso reflete o conhecimento atual de que identidades e expressões de gênero diversas **não são transtornos mentais** e que **rotulá-las como tais pode causar estigma significativo**."

Esclarece-se que o Brasil, por meio do Decreto nº 26.042/1948, tornou-se membro da OMS. Na qualidade de Estado-membro da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil assumiu o compromisso de observar suas determinações e recomendações, do que decorre o dever de cumprimento da citada Classificação CID-11. Trata-se, pois, de um dever assumido pelo Estado em âmbito internacional.

Em harmonia com esse marco normativo, o **Supremo Tribunal Federal (STF),** nos julgamentos da ADI 4275 e da ADPF 787, **afirmou a inconstitucionalidade de práticas que subordinam o exercício da identidade de gênero a avaliações patologizantes**. Destacando o dever do Estado de **assegurar o acesso universal, igualitário e desburocratizado à saúde da população trans, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da liberdade individual**.

Na contramão desses avanços, a **Resolução nº 2.427/2025 impõe laudos psiquiátricos para o reconhecimento da identidade de gênero, veda o uso de bloqueadores hormonais e proíbe a hormonização cruzada antes dos 18 anos**. Com isso, **restabelece um modelo patologizante que associa a transgeneridade a distúrbios mentais, contrariando tanto a ciência médica atual quanto a jurisprudência constitucional e interamericana**. A exigência de diagnóstico segundo o DSM-5, bem como a submissão de adolescentes trans a barreiras de acesso infundadas, **promove uma forma institucional de estigmatização e exclusão do cuidado**.

[15] World Health Organization. Gender incongruence and transgender health in the ICD. Disponível em: https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gender-incongruence-and-transgender-health-in-the-icd

Não bastasse essa repatologização, a Resolução representa um gravíssimo retrocesso social. A normatividade anterior, expressa na Resolução CFM nº 2.265/2019 e na Portaria MS nº 2.803/2013, compunha um marco que, ainda que limitado, **permitia o acesso controlado de adolescentes trans a bloqueadores hormonais a partir do estágio Tanner II e à hormonização cruzada a partir dos 16 anos, sempre com base em protocolos científicos rigorosos e acompanhamento multidisciplinar**.

A Resolução nº 2.427/2025 eliminou esses direitos já garantidos, substituindo-os por **vedações genéricas, inflexíveis e desprovidas de base empírica**. Comparando-se o marco anterior com as novas regras, evidencia-se a **drástica involução**:

- **Bloqueio hormonal da puberdade – Res. CFM 2.265/2019:** Era permitido a partir do início da puberdade (estágio Tanner II), em contexto de pesquisa e com acompanhamento multiprofissional. **Res. CFM 2.427/2025:** Passou a ser **terminantemente proibido** para adolescentes com incongruência de gênero, **impedindo qualquer acesso** antes dos 18 anos (excetuados apenas casos de puberdade precoce patológica alheios à transexualidade). Ou seja, adolescentes trans foram privados até mesmo da possibilidade da utilização de bloqueador, **rompendo-se a perspectiva terapêutica antes existente**.
- **Hormonioterapia cruzada em adolescentes – Res. 2.265/2019:** Autorizava, em caráter excepcional e supervisionado, a introdução de hormônios sexuais secundários **a partir dos 16 anos**, desde que o atendido já tivesse iniciado a puberdade e houvesse indicação da equipe de saúde, usualmente em protocolos de estudo. **Res. 2.427/2025: Vedou totalmente** a hormonização antes dos 18 anos, independentemente da maturidade do adolescente ou do acompanhamento médico disponível. Mesmo casos consolidados de vivência trans são obrigados a esperar a maioridade para ter acesso aos hormônios, o que **representa perda de dois anos cruciais de desenvolvimento assistido**. Ademais, impôs-se burocracias adicionais (exigência de acompanhamento psiquiátrico mínimo de um ano, avaliações cardíacas e metabólicas) postergando ainda mais a efetivação do atendimento aos 18 anos completos.

- **Procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero – Res. 2.265/2019:** Permitidos a partir dos 18 anos, nos casos indicados e com prévio acompanhamento, respeitando a autonomia do indivíduo adulto. **Res. 2.427/2025:** Elevou a idade mínima para **21 anos** nos casos de cirurgias com potencial efeito esterilizante, impondo barreira inédita não existente na norma anterior. Na prática, mesmo jovens adultos aptos e plenamente conscientes de sua decisão ficaram impedidos de realizar certos procedimentos até ultrapassarem os 21 anos, **sem qualquer justificativa científica consistente para essa diferenciação etária**.

- **Despatologização vs. Patologização** – O marco anterior alinhava-se à CID-11 da OMS, evitando tratar a transexualidade como doença mental; privilegiava um **projeto terapêutico singular** e individualizado, focado no bem-estar do atendido. Já a Res. 2.427/2025 **reintroduziu a lógica patologizante**, ao exigir diagnóstico de "transtorno de identidade de gênero/disforia" nos termos do DSM-5 como condição para atendimento. Ou seja, **retomou-se a visão da transgeneridade como um distúrbio psiquiátrico**, em claro retrocesso conceitual repudiado pela comunidade científica internacional (a OMS já retirou a incongruência de gênero do rol de transtornos mentais em 2019).

Essa **ruptura normativa** imposta pelo CFM viola o **princípio da confiança legítima e da progressividade dos direitos fundamentais**. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que uma vez implementadas **políticas públicas ou regramentos que densifiquem direitos fundamentais, não pode o Poder Público retroceder injustificadamente, sob pena de ofensa ao postulado da vedação ao retrocesso**. No caso em tela, a **regressão é manifesta**: procedimentos que antes eram admitidos – sob condições controladas – foram pura e simplesmente suprimidos do alcance dos atendidos que deles necessitam. **Não houve qualquer evolução científica ou circunstância fática nova que justificasse tal retrogradação**; ao revés, as **melhores evidências científicas apontam para a manutenção e aprimoramento desses cuidados**. Ignorando esses dados, a Resolução nº 2.427/2025 se apoia em conjecturas e temores infundados (como a alegação de "surge de arrependimentos" ou "sobre-diagnóstico"), não comprovados

por estudos robustos, conforme admitido no próprio relatório do CFM. O resultado é o **esvaziamento de direitos fundamentais já incorporados ao patrimônio jurídico do grupo transgênero.**

Importante frisar que o retrocesso imposto pelo CFM atinge uma **população já em situação de acentuada vulnerabilidade social e jurídica** – crianças e adolescentes transgênero, sobretudo. Trata-se de minorias que historicamente enfrentam **estigmatização, ostracismo familiar e escolar, violência psicológica e física**, e que encontravam nas políticas afirmativas de saúde um mínimo amparo estatal para garantia de sua dignidade. Ao **eliminar esse amparo**, a resolução fere não apenas o direito à saúde (CF, art. 6º e 196) e à personalidade, mas também o **princípio da igualdade material** e **da não discriminação** (CF, art. 5º, caput), na medida em que **estabelece um tratamento excludente a demandas de saúde de pessoas trans**, sem paralelo para qualquer outra condição análoga. O resultado prático é **desproporcionalmente danoso**: retira-se dos jovens trans a possibilidade de um desenvolvimento saudável e pleno, condenando-os, na contramão das evidências médicas, a sofrer as consequências de puberdades e corpos com os quais não se identificam. Conforme salientam entidades médicas e de direitos humanos, essas alterações **"não levam em consideração evidências científicas de que esses procedimentos trazem bem-estar psicossocial para crianças e adolescentes trans"**, violando princípios da dignidade humana, da proteção integral à infância e do direito fundamental à identidade de gênero autopercebida[16].

Ao revogar garantias anteriormente vigentes, sem embasamento técnico idôneo e em detrimento de um grupo vulnerável, a Resolução CFM nº 2.427/2025 **contraria o princípio da vedação do retrocesso** e configura medida desarrazoada. Cumpre ressaltar que o direito à saúde, especialmente em sua dimensão de **direito a prestações** (art. 196 da CF), impõe ao Estado (e às entidades de regulamentação profissional, no que couber) o dever de **avançar e nunca retroceder** na concretização de níveis mais elevados de proteção. Nesse sentido, a Corte

[16] Consultor jurídico. Entidades questionam resolução do CFM que restringe terapias de mudança de gênero. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2025-abr-22/entidades-questionam-resolucao-do-cfm-que-restringe-terapias-de-mudanca-de-genero/#:~:text=Seu%20argumento%20é%20de%20que,assessoria%20de%20imprensa%20do%20STF

Interamericana de Direitos Humanos e a própria jurisprudência do STF[17] têm advertido que retrocessos em políticas públicas essenciais demandam **justificativas excepcionais**, ausentes no presente caso. Pelo contrário, **toda a experiência clínica consolidada** – nacional e internacional – aponta para a manutenção do cuidado afirmativo trans como melhor prática. A Resolução impugnada, ao **ir na contramão dessas evidências e práticas consolidadas**, rompe o equilíbrio constitucional entre a liberdade científica, a autonomia dos indivíduos e a regulamentação profissional, resultando em prejuízo irreparável a direitos básicos.

Diante do exposto, resta claro que a norma editada pelo CFM não apenas incorre em inconstitucionalidades formais e materiais, mas também simboliza um **retrocesso social inadmissível**, em ofensa ao projeto constitucional de construção progressiva de uma sociedade livre, justa e solidária, sem preconceitos (CF, art. 3º, IV). **Restabelecer as garantias suprimidas** – em especial o acesso dos adolescentes trans aos atendimentos médicos essenciais à sua dignidade – é medida que se impõe para **resguardar o núcleo mínimo de direitos fundamentais** já alcançado e evitar a perpetuação de violações graves a uma parcela hipervulnerável da população brasileira.

Trata-se, portanto, da reafirmação da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em sua prerrogativa de guardião maior da Constituição, quanto à força normativa do princípio da vedação ao retrocesso e da supremacia da proteção da dignidade e da saúde de crianças e adolescentes, independentemente da identidade extravasada pela sua subjetividade.

Assim, pede-se seja reconhecida a inconstitucionalidade da Resolução CFM nº 2.427/2025, restabelecendo-se as diretrizes anteriores e assegurando-se a observância dos preceitos fundamentais violados.

[17] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7013, relatora Ministro Carmén Lúcia. Julgada em 05 de setembro de 2023. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6278488 .

IV. DA NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA MEDIDA CAUTELAR

A matéria enfrentada é complexa e multifacetada, pois envolve questões de ordem científica e sociológica. Quando se trata de temas desafiadores, em uma sociedade majoritariamente dessensibilizada à questão, não há resposta prática e definitiva. Os conflitos sócio-políticos perpetuam-se no tempo-espaço, o que demanda a vigilância contínua do ordenamento jurídico a fim de que os ditames constitucionais sejam observados e o projeto de sociedade delimitada pelo constituinte seja, ainda que não implementado de forma imediata, desenvolvido sobre os trilhos que conduzam ao destino almejado. O julgador, mesmo que pautado em uma conduta ponderada, não se abstém do dever de tutelar os interesses contramajoritários em disputa.

O Estado Democrático de Direito é um Estado de possibilidades, não de limitações, modelo que proporciona que seus cidadãos vivam a maior potência de suas identidades, de acordo com suas escolhas. A escolha não pertence ao estado, mas sim ao indivíduo.

O fato é que a Resolução CFM nº 2.427/2025 **interrompe uma política pública implementada há 15 anos no Brasil**[18], com investimentos em pesquisa, atendimentos e elaboração de planos individualizados. Ressalta-se que os protocolos brasileiros seguem a World Professional Association of Transgender Health.

O pedido de medida cautelar objetiva a **retomada dos atendimentos** – **suspensos** pela Resolução CFM nº 2.427/2025 – voltados à admissão de novas crianças, adolescentes e adultos com incongruência de gênero em oito instituições públicas em todo o Brasil, quais sejam: i. o Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual (Amtigos), vinculado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo; ii. o Centro de Saúde Escola Barra Funda, da Santa Casa de São Paulo; iii. o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); iv. o Hospital

[18] GONÇALVES, Andre Henrique Oliveira. Protocolos do AMTIGOS In: SAADEH, Alexandre; SCIVOLETTO, Sandra (coords). Incongruência de gênero: infância, adolescência e fase adulta da vida. SANTANA DE PARNAÍBA: Manole, 2024. p. 406-23

de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); v. o Hospital Universitário Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia (UFBA); vi. a Policlínica Lessa de Andrade, da rede municipal de saúde do Recife; vii. o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e viii. o programa Aquarela, vinculado ao Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).[19]

Tem-se, pois, que um **ato do Conselho Federal de Medicina está encerrando um projeto governamental**, já que os médicos não poderão continuar realizando seu trabalho, sob pena de perder sua licença profissional. Toda a expertise adquirida pelos profissionais da área corre o risco de ser perdida, o que acarreta retrocesso de cunho científico. Inclusive, é nesse sentido a manifestação assinada por 67 colaboradores dos ambulatórios especializados em Assistência Multidisciplinar à Saúde do Transgênero, nos termos do Documento 07 em anexo. O ato do Conselho de Medicina desrespeita a atuação profissional consolidada dos profissionais que atuam na área, desconsiderando seu conhecimento e capacidade técnica para definir, caso a caso, a necessidade de cada pessoa transgênero. Retira-se o direito de tomada de decisão do profissional da ponta, tratando-o na qualidade de semi-imputável, o qual supostamente necessitaria da supervisão indispensável do Conselho de Classe para dirigi-lo em suas decisões.

É de notório conhecimento que o CFM possui atribuições exclusivamente de ordem administrativa e disciplinar. Somente lei em sentido formal pode criar obrigações ou restringir direitos, nos termos do que determina o art. 5º, II, da Constituição Federal.

Inclusive, o Supremo já assentou posicionamento nesse sentido. Cita-se:

> Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal.[AC 1.033 AgR-QO, rel. min. Celso de Mello, j. 25-5-2006, P, DJ de 16-6-2006.]

[19] AVELAR, Dani. Veja quais unidades do SUS atendem crianças e adolescentes trans. Folha de S.Paulo, São Paulo, 22 maio 2022. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/2022/05/veja-quais-unidades-do-sus-atendem-criancas-e-adolescentes-trans.shtml. Acesso em: 2 maio 2025.

A Resolução CFM n. 2.427/2025 possui inafastável vício de inconstitucionalidade formal, já que restringe direitos, inclusive aqueles atinentes à liberdade profissional, por meio de Resolução, o que somente poderia ser feito por meio de lei. Nesse sentido, detendo-se à análise perfunctória inerente à apreciação da medida cautelar, tem-se que o requisito da probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrado, ante a violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal.

A urgência do deferimento da medida cautelar decorre, sobretudo, do perigo da demora. Não se desconhece o fato de que a Resolução CFM nº 2.427/2025 determinou em seu art. 10 que, "as disposições desta Resolução não se aplicam a pessoas que já estejam em uso de terapia hormonal ou bloqueadores da puberdade." Todavia, impossibilitou-se que novos acompanhamentos fossem realizados, inviabilizando a admissão de novos atendidos.

O dano é irreparável.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, no que tange às crianças, nunca houve protocolo para administração de bloqueadores e/ou utilização de terapia hormonal. Portanto, a repristinação da antiga Resolução CFM nº 2.265/20219, em nada afetaria à disciplina relativa às crianças. Trata-se de faixa etária em que apenas se realiza atendimentos médicos pediátricos e psicossociais, o que continua sendo permitido pelo novo texto legal.

O cenário, contudo, é diverso para o caso dos adolescentes. A adolescência é fase crucial para o desenvolvimento físico e psíquico do indivíduo. A utilização de bloqueadores previne prejuízos irreversíveis, cuja reparação exigiria a submissão a procedimento cirúrgico posterior. É o caso do crescimento das mamas e da proeminência laríngea. Contudo, além da questão cirúrgica, tem-se a prevenção quanto à alteração de voz, crescimento de pelos indesejados, episódios de ereção e início da menstruação.

Além da proibição do bloqueio hormonal, vedou-se a hormonização a partir dos 16 anos e a realização de procedimento cirúrgico antes dos 21 anos, nos casos em que há esterilização.

Ocorre que, nos termos da vasta literatura juntada à inicial, a ausência de atendimento institucionalizado promove o agravamento do quadro psíquico do indivíduo, o qual não se identifica com o seu gênero de seu nascimento. O próprio parecer do CFM (Documento 05), utilizado para a elaboração da resolução ora impugnada, aponta que o acompanhamento sempre foi indicado como uma forma de aliviar o sofrimento do indíduo, inclusive prevenir casos extremos de suicídio.

Estudos como o de Sorbara et al. (2020) demonstram que adolescentes trans que acessam cuidados afirmativos tardiamente apresentam índices significativamente maiores de depressão, automutilação e tentativa de suicídio. A ausência de intervenção adequada pode multiplicar por mais de cinco vezes o risco de depressão e quadruplicar o de transtornos de ansiedade. Esses dados se somam a levantamentos como o da Associação Americana de Psiquiatria, que apontam taxas alarmantes de tentativas de suicídio entre adolescentes trans (41%, frente a 14% entre os demais jovens). Assim, a não concessão de medida cautelar ocasionará agravamento do quadro de depressão, mutilação e suicídio de jovens, cuja mensuração é de difícil dignóstico.

Esclarece-se que o CFM afirma que não há dados científicos suficientes para justificar a continuidade dos acompanhamentos. Ocorre que a literatura, devidamente apontada no parecer anexo à Resolução, demonstra o contrário. As pesquisas demonstram que os atendimentos são efetivos para reduzir o sofrimento dos atendidos, do que se denota a revogação de um protocolo sem embasamento de cunho científico.

Em suma, o perigo da demora assenta-se nas seguintes premissas: i. risco de dano irreversível ao adolescente que não tem acesso ao bloqueio hormonal, cuja reparação desejada apenas se dará por meio de cirurgia; ii. desmonte de uma política pública vigente há quinze anos no Brasil, com profissionais de ponta, estrutura e conhecimento científico adquirido pela vasta experiência no decorrer do tempo; iii. agravamento do sofrimento psíquico daqueles que necessitam da intervenção hormonal e/ou procedimento cirúrgico, incluindo a ocorrência de episódios de mutilação e, até mesmo, suicídio; iv. incentivo à clandestinidade, uma vez que a ausência de meios formais de atendimento pode ensejar o recurso à clandestinidade e os consequentes riscos à saúde dos cidadãos.

Requer-se, portanto, suspensão da eficácia da Resolução CFM nº 2.427/2025, com a consequente repristinação da Resolução CFM nº 2.265/20219, uma vez caracterizados os requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora, previstos no art. 5º da Lei nº 9.882/99 e nos arts. 5º, inciso XII, art. 21, inciso V e art. 170 do RISTF.

V. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Partido Socialismo e Liberdade:

a) A distribuição por prevenção desta presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental à ADI n.º 7806, tendo em vista ser prevento o Eminente Ministro Zanin, nos termos do que dispõe o art. 69 do Regimento Interno do STF;
b) A admissão e o conhecimento desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental;
c) A concessão da medida liminar monocraticamente pelo Ministro Relator, *inaudita altera pars* e *ad referendum* do Plenário, nos termos do art. 5º, §3º da Lei 9.882/1999, para suspender a eficácia da Resolução nº 2.427, de 8 de abril de 2025, do Conselho Federal de Medicina (CFM);
d) A confirmação da medida cautelar pelo Plenário, mantendo-se suspensa a eficácia da resolução impugnada até o julgamento final da presente ação;
e) A notificação do Conselho Federal de Medicina para que cumpra a cautelar deferida;
f) Seja notificado o Exmo. Procurador Geral da República para que emita o seu parecer e intimado o Advogado-Geral da União para se manifestar, na forma do art. 103, §3º, da CF/88 e art. 5º, §2º da Lei nº 9.882/99;
g) A requisição de informações adicionais ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 6, §1º, da Lei 9.882/1999, sendo o órgão responsável pelo estabelecimento de parâmetros das políticas públicas em saúde;
h) A procedência do pedido de mérito, para declarar inconstitucional a Resolução nº 2.427, de 8 de abril de 2025, do Conselho Federal de Medicina (CFM), com repristinação dos efeitos da Resolução CFM nº 2.265/2019.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em razão da impossibilidade de quantificar seu conteúdo econômico.

Termos em que, pede deferimento.

Brasília, 02 de maio de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA DE FREITAS DO AMARAL
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

RAPHAEL SODRÉ CITTADINO
OAB/DF N.º 53.229

BRUNA DE FREITAS DO AMARAL
OAB/DF N.º 69.296

PRISCILLA SODRÉ PEREIRA
OAB nº 53.809-DF

ARTHUR NINO SILVA FONSECA
OAB nº 65.948-DF

LISTA DE ANEXOS

Doc. 1 - Resolução nº 2.427, de 8 de abril de 2025;

Doc. 2 – Procuração;

Doc. 3 - Estatuto PSOL;

Doc. 4 - Certidão SGIP PSOL;

Doc. 5 - Exposição de motivos da Resolução CFM N° 2.4272025;

Doc. 6 - Veja quais unidades do SUS atendem crianças trans (Equilíbrio - Folha);

Doc. 7 - Nota dos colaboradores dos Ambulatórios;

Doc. 8 - Tabela Comparativa CASS x Brasil.